当院における複数菌菌血症での嫌気性菌分離状況

過去２年間における検出菌種の解析

◎村松 早智子[1)]、山口 明彦[1)]、川本 怜子[1)]、浅見 亜季[1)]、西村 夏嬉[1)]、渡邉 邦友[1)]
社会医療法人厚生会 中部国際医療センター[1)]

【目的】嫌気性菌は複数菌菌血症を引き起こしやすいことが知られている。本研究では，市中二次救急医療機関の単一施設における外来・救急患者を対象とし，嫌気性菌が関与する複数菌菌血症の検出状況を後向きに検討した。

【方法】 2022 年 1 月から 2023 年 12 月の 2 年間において，当院の外来および救急外来を受診し，血液培養検査によって菌血症と認められた症例を対象とした。血液培養装置は BACTEC FX（日本 BD 社），血液培養ボトルは BD バクテック 23F 好気用レズンボトル P, BD バクテック 21F 溶血タイプ嫌気用ボトル P を使用した。培養日数は最長 7 日間とし，陽性となったボトルは所定の方法でサブカルチャーした。菌種同定には，質量分析装置 MALDI Biotyper Sirius（ブルカージャパン社）ver.11(10833)を用いた。

【結果】対象期間中に検出された菌株数および症例の内訳を調査し「単一菌菌血症」と「複数菌菌血症」に分類した。菌血症と認められたのは 575 症例であり，総検出菌株数は 673 株であった。症例の内訳は，全菌血症 575 症例のうち嫌気性菌血症は 56 症例（56/575，9.7%）であった。全複数菌菌血症 72 症例のうち，嫌気性菌血症は 30 症例（30/72，41.7%）であった。単一菌菌血症 503 症例のうち，嫌気性菌血症は 26 症例（26/503，5.2%）であった。一方，嫌気性菌総分離株 71 株のうち単一菌菌血症から 26 株（26/71，36.6%）が，複数菌菌血症から 45 株（45/71，63.4%）がそれぞれ分離された。

【まとめ】 嫌気性菌は複数菌菌血症として検出され，その中でも菌種別では *Clostridium perfringens* が 76.9%（10/13 株）と高く，次いで *Bacteroides fragilis* 33.3%（6/9 株）であった。*C.perfringens* の同時分離菌としては，検出された 12 株のうち *Klebsiella pneumoniae* 44.4%（4 件）, *Escherichia coli* 33.3%（4 件）が占めた。*C.perfringens* 菌血症は稀ではあるが致死率は報告によっては 50%を超えることがあり最も重篤な菌血症の一つである。また MIH が発生するとさらに致死率は高くなるため検査現場においては臨床への迅速な同定結果の報告が重要である。

中部国際医療センター臨床検査技術部
村松早智子（代表：0574－66－1100　内線：4580）